

Fièvre Typhoïde

Dr A Filali

Service Des Maladies Infectieuses

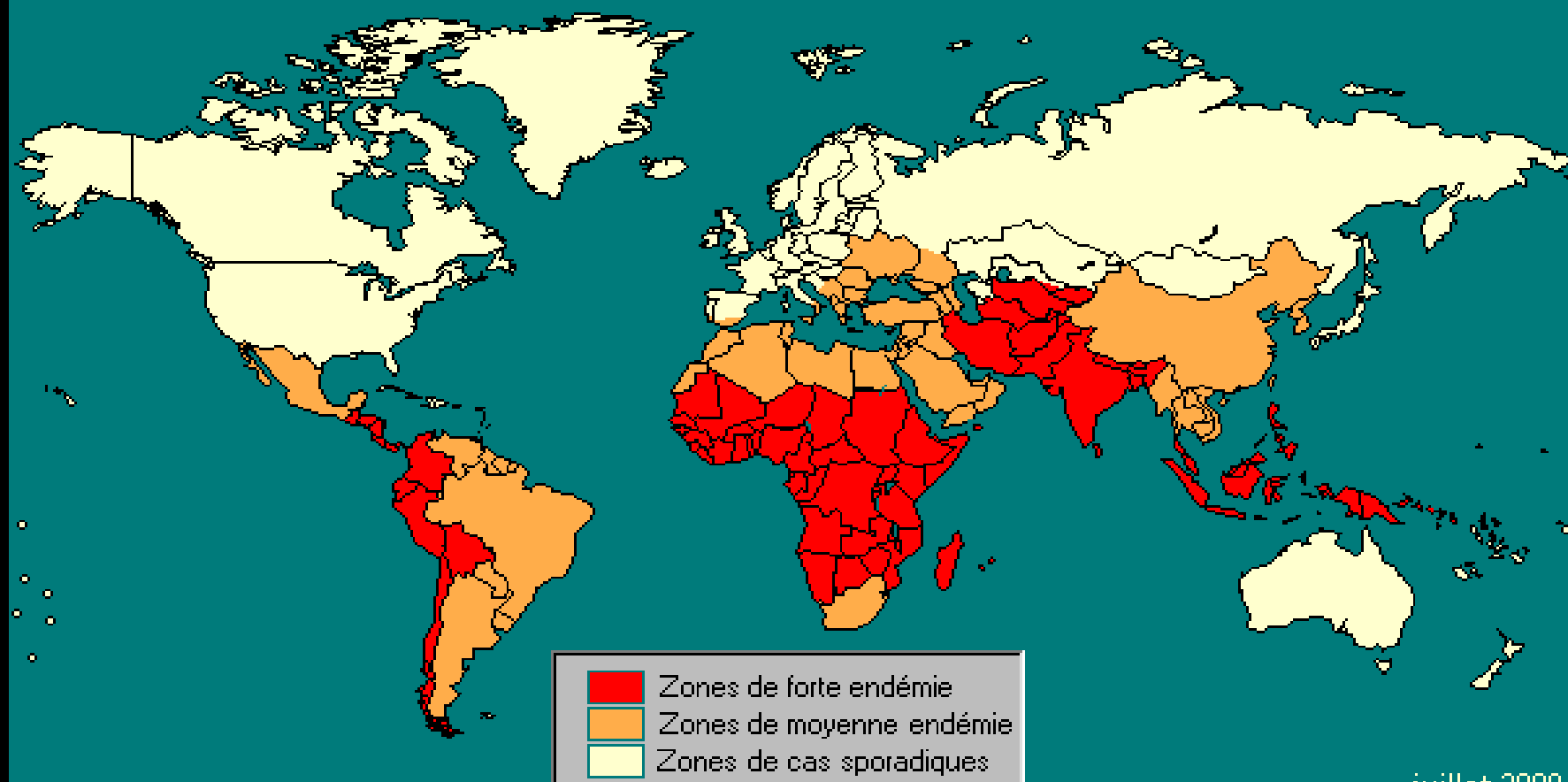
Faculté De Médecine

Université de Constantine 3

I. Définition

- La fièvre typhoïde est un problème de santé publique en Algérie
- Une maladie infectieuse transmissible à déclaration obligatoire
- Toxi-infection, contagieuse ,endémo-épidémique due à *Salmonella entérica* sérotypes Typhi (bacille d 'Eberth) et Paratyphi A,B ou C

FIEVRE TYPHOÏDE



juillet 2000

II. Epidémiologie

- Aujourd'hui : endémo-épidémique ; toutes les wilayates ,des foyers traditionnels (Batna,Tlemcen, Tiaret, Annaba...) 4834 cas en 1997
- 1 Agent causal : germes responsables : salmonella enterica sérotypes Typhi,Paratyphi A,B et C Bâtonnets ciliés, mobiles Comporte 3 antigènes : Ag O somatique, glucido-lipidique, c'est l'endotoxine , Ag flagellaire ,protéique, Ag Vi de surface :S.Typhi et C

II. Epidémiologie

- 2 le réservoir de germes: strictement humain: malades/convalescents/porteurs chroniques

- 3 la transmission peut être :

Directe : une maladie des mains sales, transmission manu-portée : contact avec les selles infectées, du linge souillé ou absorption d'aliments manipulés par un porteur de germes

Indirecte : le plus souvent: ingestion d'eau souillée, d'aliments, de coquillages crus contaminés.

III. Physiopathologie

- 1 - La fièvre typhoïde est une septicémie bien particulière
 - a) sa porte d'entrée est intestinale et après ingestion d'aliments ou de boissons souillés, les germes, issus de l'intestin sont véhiculés par les chylifères jusqu' 'aux ganglions mésentériques où ils se multiplient .
 - b) son point de départ est adéno-lymphatique : tout commence donc par l'adénite mésentérique; c'est dans les ganglions que les germes se multiplient avant d'être déversés dans le courant sanguin et déterminent les localisations métastatiques
- 2 - La fièvre typhoïde est surtout une toxi-infection et les signes de la maladie sont le fait de l'action de l'endotoxine typhoïdique sur le système nerveux neuro-végétatif.

III. Physiopathologie

- Anatomie pathologique :

Les lésions des ganglions mésentériques et des formations lymphoïdes de l'intestin sont caractéristiques.

Schématiquement, elles évoluent en 3 stades: infiltration inflammatoire, mortification avec nécrose, répartition fibreuse.

Les zones nécrosées des ganglions mésentériques, où les ATB arrivent mal, constituent des gîtes microbiens qui peuvent être le point de départ d'une rechute si le traitement est insuffisamment prolongé, prédominant à la partie terminale de l'iléon au niveau des plaques de Peyer et évoluent vers la nécrose et l'ulcération d'où risque d'hémorragies et de perforations. Elles s'accompagnent d'atteinte artériolaire proliférante et thrombosante.

IV. Clinique

- La fièvre typhoïde dans sa forme commune chez le sujet non vacciné, est une maladie cyclique qui réalise un syndrome général toxi-infectieux progressif avec signes digestifs
- L'incubation: silencieuse de 15 jours.
- Elle évolue en 3 septénaires (périodes de 7 jours)
 - A. I-L'invasion ou 1er septénaire : début insidieux marqué par :
 - 1- des signes fonctionnels :
 - troubles digestifs : anorexie, constipation
 - troubles neurologique : céphalées persistantes, insomnie, asthénie physique et psychique
 - Épitaxis, unique très évocatrice

IV. Clinique

- 2 - des signes généraux :

la fièvre d'ascension progressive; elle atteint 39 à 40° en 4 à 7 jours

le pouls ne s'accélère pas autant que ne le voudrait la T°:c'est déjà un début de dissociation pouls/T°

- 3- les signes physiques sont pauvres à ce stade et sont constitués par :

Météorisme abdominal avec souvent constipation

Une FID sensible et gargouillante

Une splénomégalie discrète apparaît vers le 5^{ième} jour

Une langue saburrale, rarement une angine de Duguet:
ulcération unilatérale

L'auscultation pulmonaire de petits râles fins bronchiques
aux 2 bases

IV. Clinique

- II -Phase d 'état (2e septénaire):

Le tableau clinique se complète

1 -Signes fonctionnels

Le tuphos : malade est prostré, inerte, indifférent; il répond difficilement aux questions. Ce tuphos s'accompagne d'un délire onirique (de rêve), doux et tranquille avec des mouvements (mouvements stéréotypés), d'une inversion du sommeil

La diarrhée caractéristique : liquide, fétide, de couleur ocre (ou « jus de melon ») émise sans douleurs, sans colique.

2 -Signes Généraux :

La T° est en plateau à 40° ; le pouls est dissocié (90 à 100)

IV. Clinique

- 3- Signes Physiques:

Une FID sensible et gargouillante

Une splénomégalie est de type septicémique.

Les TRL : inconstantes mais pathognomoniques : de petites macules rosées rondes ou ovalaires de 2 à 3 mm de diamètre

Le reste de l'examen clinique montre :

une langue sèche et saburrale, des râles bronchiques fins aux 2 bases

V. Evolution

1-sans traitement ,dans l'évolution spontanée, survenait la défervescence qui se faisait progressivement avec le plus souvent de grandes oscillations thermiques. Avec une convalescence longue et des complications fréquentes (décès 15%)

2- avec traitement, l'évolution est le plus souvent rapidement favorable. La T° décroche vers les 3 - 4^{ième} jours et l'apyrexie, après une chute en lysis de la T°, est obtenue vers le 7-8^{ième} . Cependant des rechutes sont encore possibles

VI. Formes cliniques

- I- Formes symptomatiques

- 1 _ les formes à début brutal .

- 2 _ les formes atténuées : la classique diarrhée le typhos peuvent manquer

- 3 _ les formes graves avec un collapsus cardio-vasculaire, des signes abdominaux avec syndrome pseudo-occlusif ou pseudo-perforatif, des manifestations encéphalitiques et parfois un syndrome hémorragique

- II-Formes selon le terrain

- 1 _ La forme du nourrisson est rare et s 'exprime généralement par une gastro-entérite infectieuse avec déshydratation

- 2-chez l 'enfant le début peut être brusque ou brutal, avec expression méningée. La NFS peut noter une hyperleucocytose.

- 3-Chez le vieillard, la FT est rare. Les manifestations cardio-vasculaires et pulmonaires sont au premier plan

- 4-Chez le femme enceinte ,la FT non traitée entraînait fréquemment l'avortement

VII. Les complications de la FT

les complications de la FT peuvent atteindre tous les organes

1° les complications digestives :

a) les hémorragies intestinales, survient vers le 3^{ème} septennaire. Soit minime ou cataclysmique l'hémorragie intestinale est annoncée par une chute thermique brutale et se traduit par une émission plus ou moins abondante de sang (rouge ou brunâtre).

b) les perforations intestinales demeurent une complication grave. Elles réalisent 2 formes cliniques :

la forme sthénique facile à reconnaître devant un tableau d'abdomen chirurgical aigu.

la forme asthénique survenant chez un malade en plein typhos, est de diagnostic plus difficile.

2 examens ont alors une grande valeur : l'hémogramme qui montre hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile et l'ASP qui objective un pneumopéritoine sous forme d'un croissant clair gazeux sous diaphragmatique

VII. Les complications de la FT

- c) Le syndrome abdominal pseudo-perforatif observé dans certaines formes graves traitées tardivement par des doses fortes de Chloramphénicol et du à une libération importante d 'endotoxine, pose un problème difficile de diagnostic différentiel avec la perforation intestinale asthénique; mais dans ce cas, l'ASP ne montre pas de croissant gazeux.
- d) les complications hépato-biliaires : abcès hépatiques, ictère typhoïdique, cholécystites

VII. Les complications de la FT

- 2° les complications cardio-vasculaires
 - a) la myocardite typhique : ECG
 - b) le collapsus cardio-vasculaire qui s 'observe dans les formes graves
- 3° les complications nerveuses sont dominées par
 - a) l 'encéphalite SURTOUT CEREBELLITE
 - b) les méningites typhoïdiques sont exceptionnelles; mais il est fréquent d 'observer dans les FT graves un méningisme

VIII. Le diagnostic positif

- 1° certains examens complémentaires ont une valeur d'orientation
 - a) l'hémogramme :leucopénie
 - b) la VS est normale ou peu accélérée
- 2°les examens de certitude sont:
 - a) l'hémoculture elle est + surtout au cours des 10e jours de la maladie
 - b) la coproculture est moins souvent positive que l'hémoculture en début de maladie..
 - c) le sérodiagnostic de Widal et Félix classiquement, les agglutinines apparaissent entre le 8 et 12 j les Ac H apparaissent vers le 10-15 j , s'élèvent ensuite rapidement pour persister des années les taux d'Ac exigés sont d'au moins 1/100 pour les anti O

Le diagnostic différentiel peut se poser avec les fièvres en plateau
paludisme de primo-invasion tuberculose rickettsioses PFLA

IX. Traitement

- I-Armes thérapeutiques

- A-les antibiotiques

- 1- ATB classiques

- a) le Chloramphénicol a été pendant longtemps l'ATB ,le seul ATB efficace de la FT. Il faut savoir que: ne passe donc pas dans la vésicule biliaire n'est plus utilisé vu l'atteinte hématologique qu'il peut provoquer durée prolongée (21 j soit 15j après l'apyrexie)

- b) le Thiamphénicol (TAP) présente 2 avantages par rapport au CAP s'élimine sous forme active au niveau de la vésicule biliaire il n'a jamais été observé d'aplasie médullaire avec le TAP cependant érythroblastopénie réversible possible

- c) les Pénicillines A l'Amoxicilline qui passe bien la barrière intestinale résistance possible

- d) Co-trimoxazole très efficace

- 2°_ nouveaux ATB : a) les céphalosporines de 3^{ème} génération et particulièrement la Ceftriaxone b) les fluoroquinolones :leur intérêt réside dans leur utilisation en traitement court dans leur efficacité contre les Eberth R.

IX. Traitement

- B- Les corticoïdes ne doivent être utilisés que dans des cas précis: encéphalite ,complications cardio-vasculaires , syndrome pseudo-perforatif
- C- Autres médicaments : Perfusion de macromolécules, transfusions sanguine, équilibre hydro- électrolytique et énergétique

3-Traitement des complications

- hémorragies digestives: transfusion
- perforations: chirurgie
- syndrome pseudo-perforatif :arrêt de l 'ATB, corticoïdes, sonde rectale
- complications cardio-vasculaires : grosses molécules, corticoïdes, apport énergétique
- encéphalite : corticoïdes, nursing

IX. Traitement

- Prophylaxie :
 - * isolement du malade,
 - * déclaration de la maladie
 - * désinfection des excréta en cours de maladie,
 - * recherche porteurs sains, trt difficile
 - * assainissement du milieu (contrôle sources d'eau, aliments)
 - * éviction porteurs chroniques des personnels cuisine
 - * Vaccination : vaccin polysidique capsulaire Typhim qui a remplacé le TAB contre S.Typhi □ bien toléré 1 inj + rappel tous les 3 ans à partir de 2 ans